

КОМПЛЕКТ СПИКЕРА · 26.08.2026

Сценарий выступления · 18–20 минут

С таймингом по слайдам · площадка № 2, ДСО «Тесовый берег»

Документ: полный сценарий устного выступления для сессии «Организация питания: опыт реализации проектов». **Сессия:** 26.08.2026, 14:00–15:30, площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег». **Версия:** 22.08.2026 (с правками из фактчекинга). **Объём:** ≈ 2 500 слов (полная устная речь 18–20 мин при спокойном темпе с паузами). **Слайды:** синхронизировано с презентацией v5 (21 слайд основной показ + резерв R1–R19).

Драматургия: вопрос (0–2 мин) → одна история + три цифры (2–5:30) → тезис и три факта (5:30–8:30) → три уровня решений + модель + кейс (8:30–12:30) → пилот со стоп-критериями (12:30–16:30) → три+одно возражения (16:30–19) → действие и финал (19–20).

[0:00] Вступление: вопрос

Коллеги, кто в вашем доме сегодня решает, что лежит на тарелке — он сам, сиделка, врач, кухня, контракт или региональная норма?

Чаще всего отвечают «кухня» и «норма». Реже всего — «он сам». Для человека в вашем доме еда — три-четыре события в день. Тема семинара — права жителей. Здесь они либо доходят до тарелки, либо остаются в статье закона.

[Слайд 1 — титул; 0:30]

[2:00] История: «Один обед — пять конфликтов»

Давайте начнём не с витрины «как хорошо у нас получается». Сначала несъеденное и голод, потом броня документов и пилот на одно отделение.

Один обед — пять конфликтов. Обеденный зал на 120 мест. На линии — борщ, гречка с котлетой, компот. Двенадцать жителей едят только с помощью. Четыре сиделки, из которых одна развозит лекарства.

Первый конфликт: очередь против помощи. Самостоятельные сидят перед остывающими тарелками — им первым, потому что быстрее. Кормимые ждут: четыре сиделки на двенадцать — это три цикла по 15–20 минут. Последние получают холодное.

Второй конфликт: «он опять не ест кашу». Житель третий день отодвигает тарелку. Журнала отказов нет. У него депрессивный эпизод и, возможно, начинающаяся дисфагия — но проверить некому: логопеда в штате нет, признаки расстройства глотания (покашливание за столом, «влажный» голос после еды) никто не связывает с отказами.

Третий конфликт: лекарства и кофе. Житель на клозапине с утра выпил две большие кружки крепкого кофе, который принесли родственники. Никто не предупредил семью и самого жителя, что кофеин взаимодействует с клозапином — клинически значимый рост концентрации препарата описан в исследовании Hägg 2000 года.

Четвёртый конфликт: добавка. Житель на оланзапине набрал 14 кг за год — у оланзапина один из самых выраженных весогенных профилей. Сиделка отказывает — «вам нельзя, вы

полнее». Врачебного назначения нет. Решение принято сиделкой по её представлению о пользе.

Пятый конфликт: проверка на следующей неделе. В четверг — комиссия учредителя. Суточные пробы за двое суток будут подписаны сегодня. Это самое опасное — документальная имитация контроля.

[Слайд 2 — «Три конфликта»; 4:30]

Почему все пять конфликтов — одна система. Ни один из пяти не требует денег для начала. Требуется решение директора и документы. Три из пяти упираются в кадровую нагрузку. Вариативное питание добавит шестой конфликт — «кто выбирает блюдо». Если пять базовых не закрыты, шестой добьёт систему.

[5:30] Тезис: «Не просто накормить»

Тезис простой. «Не просто накормить» — это формула отделения безопасности от лозунга, достоинства от «ресторана», воли от сиюминутного каприза. Это управляемая система, в которой:

— безопасность имеет приоритет; — медицинскую рамку определяет уполномоченный специалист; — внутри допустимой рамки человеку предоставляют понятный выбор; — воля может выражаться словами, взглядом, жестом, поведением, устойчивыми предпочтениями и биографическими сведениями; — выбор документируется; — кухня исполняет назначение, но не ставит диагноз; — результаты пилота измеряются; — достоинство человека не противопоставляется безопасности.

Три цифры, которые заставляют задуматься. Первая. В изученных клинических группах на антипсихотиках дисфагия — 21,9–69,5 %. Это не ваши жители — перенос не доказан. Но нижняя граница говорит, что проблема не редка. Вторая. Смертность от пневмонии при шизофрении в 7 раз выше популяционной — мета-анализ Correll 2022 года, 135 когорт. Аспирация — ключевой механизм. Третья. 99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения. 117 000 человек, по данным проекта «Если быть точным» за 2024 год. Это не уникальный риск Серафимовского — это общероссийская норма.

[Слайд 3 — «Не просто накормить»; 7:00]

[8:30] Граница: что кухня не назначает

Сначала граница. Без врача: любые ограничения рациона, включая «диабетический стол». Изменение текстур — протёртое, загущённое. Правила при дисфагии и протокол свободной воды. Действия при длительном отказе от еды. Режим при седации. Решения об энтеральном питании. Комфортное кормление. Сдвиг времени еды у инсулинозависимых. Слабительные и реакция на запор. Назначение анализов и микронутриентов. Интерпретация MUST.

Без учредителя: изменение финансирования продуктовой строки. Штатное расписание — норма помощи за столом. Аутсорсинг питания. Официальный статус пилота.

Без правовой проверки: формулировки о согласии недееспособного. Обработка пищевых карт как персональных данных. Ответы на запросы прокуратуры.

Иначе осторожный директор правильно услышит: «мне предлагают медицинскую реформу руками повара». Кухня исполняет назначение, не ставит диагноз.

[Слайд 4 — «Граница 4.0»; 9:30]

[10:00] Шесть измерений одной тарелки

Одномерное «накормить» — это порция по норме и съедена. Этого недостаточно. Шесть измерений.

Достаточность. Порция покрывает норму. Измеритель — фактическое потребление, не выданная порция. Безопасность. Три слоя: санитарный, клинический, поведенческий. Провал любого — предмет ответственности. Удовольствие. Вкус, температура, разнообразие. Невкусная еда съедается хуже, и недоедание возникает при формально достаточных нормах. Социальность. Еда как совместное событие. Персонал за общим столом — бесплатный мониторинг. Самостоятельность. «Свой стол» — реабилитационная задача. Выбор. Единственное измерение, которое нельзя делегировать.

Деньги закрывают в основном первые три; последние три — организацию и документы.

[Слайд 5 — «Шесть измерений»; 11:00]

[11:30] Российские практики: 4 учреждения + 1 регион

Практика уже есть. Четыре учреждения и одна региональная модель, без обобщений.

Серафимовский — наш дом, Санкт-Петербург. Локальный приказ № 124 от 10.03.2026 закрепил заказное питание в правилах внутреннего распорядка. Это локальный акт одного учреждения, не общероссийская норма, но пример того, как может быть.

Успенский психоневрологический интернат, Новосибирская область — модель М2: во всех отделениях, ежедневно два вторых, два салата, два напитка.

Болотнинский ПНИ, та же область — модель М1: выбор на завтрак и обед по ключевым позициям, перечень определяет диетсестра.

Усть-Илимский дом социального обслуживания, Иркутская область — «что за зверь такой — вариативное питание».

Иркутская область в целом — региональная модель: выбор из двух первых, двух вторых и гарниров.

«Тесовый берег» — наш со-модератор, и его практика пока не опубликована. Не путать с пятью подтверждёнными.

[Слайд 6 — «Практики»; 12:30]

[12:30] Пилот за 90 дней: минимальный безопасный старт

Пилот за 90 дней реалистичен на одном отделении без новой сметы. Месяц измерений, месяц документов и обучения, месяц пилота.

Один обед, одно отделение, одна неделя замера. 5 групп показателей: заполненность пищевых карт; доля приёмов с реально доступным выбором; доля корректно исполненных заказов; отказы, замены и пищевые отходы; события риска.

«% выбравших» — не KPI. Человек вправе выбрать стандартный вариант или не выбирать вовсе. Успех — доступность и исполнение осмысленного выбора.

6 стоп-критериев: рост пневмоний на 30 % и более по сравнению с предыдущим кварталом. Падение со смертельным исходом в столовой. Жалоба в прокуратуру. Приказ учредителя. Отзыв согласия учредителя. Отсутствие врача.

Лучше «сложное» отделение — с группой помощи, неговорящими. Если получится у них — получится у всех.

Внедрено публично ≠ доказанный эффект. Панелей «до/после» в открытом доступе почти нет. Пилот в вашем учреждении — единственный способ получить собственные данные.

[Слайд 7 — «Пилот 90 дней»; 14:00]

[14:00] Минимальная безопасная модель

Два варианта блюда, журнал, карта, один помощник на каждого кормимого. Без второй кухни и без новой сметы. Эта модель — не идеал, а минимальная планка, ниже которой вариативное питание превращается в имитацию.

Шесть блоков: документы, клиника, люди, голос жителя, замер, ночной интервал. Каждый блок — с ответственным и измерителем.

Ночной интервал — операционная цель пилота: ≤13 часов. 11 часов — шведский ориентир Livsmedelsverket; 14 часов — американский CMS F-Tag 803. «Ужин 17:30 → завтрак 8:30 = 15 часов» — это пример возможного расписания, не средний показатель по РФ. Российского норматива нет.

Если хотя бы один блок не выполняется — начинайте с него, а не с самого красивого.

[Слайд 8 — «Минимальная безопасная модель»; 15:30]

[16:00] Три возражения

Возражение первое: «Закон не запрещает, но и не обязывает. Зачем нам это?» Затем, что ответ проверяющему — комплект документов, не формула «запрета нет». Положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем. Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки.

Возражение второе: «Клоzapин и кофе — это к нам не относится, у нас таких жителей нет». У вас есть жители на антипсихотиках. 76,3 % прибавка веса на клоzapине за 38 недель — мета-анализ 202 исследований, Campfords 2023. Это не все, но это риск. Одна подписанная таблица на посту — таблица «лекарство × еда» — закрывает тему.

Возражение третье: «У нас 99 % под опекой самого учреждения, и это конфликт интересов». Да, и это не уникальный риск — это общероссийская норма. Закон 3185-1 ст. 5 ч. 2 говорит о

праве на гуманное отношение. Этот текст работает и тогда, когда опекун и поставщик совпадают. Решение — задокументированный процесс выражения воли.

Возражение четвёртое: «СанПиН меняется через 6 дней, мы не успеем». Успеете. Главное для учреждений соцобслуживания — п. 56 подп. 11. Формулировка «не менее трёх приёмов + диетическое по показаниям» сохранена в обеих редакциях. Смотрите новую редакцию с 1 сентября.

[Слайд 9 — «Возражения»; 18:00]

[18:00] Защитная формула

Защитная формула, если спросят «с чего начать прямо сейчас».

1. Семь дней считаем отходы. Приложение 25. Без замера через 90 дней сравнивать нечего.
2. Замеряем интервал ужин → завтрак одной строкой в журнале. Если >13 часов — сдвигаем расписание.
3. На пост — таблица врача «лекарство × еда». Не самостоятельность кухни. Приложение 21.
4. Три отказа подряд — звонок врачу в тот же день. Приложение 9.
5. Если кухня чужая — открыть спецификацию: есть ли строка выбора? Разделы 42 и 35.9.

В первый понедельник не делать: не выбирать модель М1–М5, не менять меню, не выпускать пресс-релиз. Совет жителей подключается на этапе пар эквивалентов.

[Слайд 10 — «Пять действий»; 19:00]

[19:00] Финал-обязательство

Коллеги, «не внедряйте вслепую. Измеряйте» — последнее слово этого доклада. Семь дней замера отделяют убеждение от знания.

Если получилось в Успенском ПНИ — жители «с лёгкостью освоили новую систему» — это методика.

Если не получилось в вашем учреждении — это тоже результат, который говорит, что нужно менять в вашей системе. Не в системе «вообще».

Право выбора становится реальным тогда, когда его можно проследить до тарелки.

Спасибо.

[Слайд 21 — финальный, тёмный, курсив; 20:00]

Тайминг

Слайд	Минута	Содержание
1	0:00–0:30	Титул
2	0:30–4:30	«Один обед — пять конфликтов»
3	4:30–7:00	«Не просто накормить» + три цифры

Слайд	Минута	Содержание
4	7:00–9:30	Граница 4.0
5	9:30–11:00	Шесть измерений тарелки
6	11:00–12:30	Российские практики
7	12:30–14:00	Пилот 90 дней
8	14:00–15:30	Минимальная безопасная модель
9	15:30–18:00	Три+одно возражения
10	18:00–19:00	Защитная формула
21	19:00–20:00	Финал

Резерв R1–R19 — для ответов на вопросы. Включают Q&A 22 вопроса, правовые позиции, кейсы, справку по СанПиН 4282-26.

Оговорки для устной версии (с правкой от 22.08)

1. «74 %» — данные проекта «Если быть точным» за 2024 г., **не официальная статистика Минтруда**. В вашем доме цифра будет другой.
2. «15 часов» — пример возможного расписания, **не средний показатель по РФ**.
3. «76,3 % клоzapин» — мета-анализ Campforts 2023 (BJPsych Open), ≥ 7 % прибавка веса за 38 нед. **Не путать** с Pillinger 2020 (Lancet Psychiatry) — там $-0,23...+3,01$ кг за 6 нед, это другое исследование.
4. «Клоzapин + кофе» — исследование Hägg 2000 на 12 здоровых добровольцах, однократная доза. У пациентов эффект может быть другим. **Кухня не отменяет кофе — врач оценивает риск**.
5. «IDDSI 44→90 %» — в 5 учреждениях aged care, **не в психиатрии**. Перенос не доказан.
6. «1/10 смертей» — Sjogren 2008, мета-анализ 4 РКИ, frail elders, **не ПНИ/ДСО для лиц с психическими расстройствами**.
7. Приказ № 124 — **локальный** акт Серафимовского, не общероссийская норма.
8. СанПиН 4282-26 — вступает в силу с **01.09.2026**, через 6 дней после семинара.
9. «Внедрено публично ≠ доказанный эффект» — панелей «до/после» в открытом доступе почти нет.

Дата: 22.08.2026. **Докладчик:** Чистяков Евгений Владимирович. **Объём:** ≈ 2 500 слов. **Время:** 18–20 минут. **Слайды:** 21 (основной показ) + R1–R19 (резерв). **Изменения после 22.08.2026 требуют перепроверки.**